

01 - 1-faiblesse de la paroi sono maker

... .. On commence donc par le courbe de la faiblesse de la photoarmoire d'Ormina. Comme introduction, on va dire que la pathologie de la faiblesse de la photoarmoire d'Ormina, ce sont les hernies et les éventrations. Ce qu'on appelle les hernies et les éventrations, on les définit par une défaillance de la paroi abdominale frontérolatérale.

Vous savez très bien que la paroi frontérolatérale est musculaire. Vous avez vu dans le cours de la première année les muscles de la paroi abdominale. En avant, vers l'année médienne, vous avez les deux grands muscles de la paroi abdominale qui sont verticaux.

Ils sont liés par trois muscles interposés de la superficie à la profondeur, à savoir le muscle grand oblique, le petit oblique et le muscle transverse. Alors ces muscles ont comme rôle en fonction des viscères qu'on a dans la paroi abdominale. Vous savez très bien que les viscères à l'intérieur de l'ancienne paroi abdominale sont sous une pression positive.

Maintenant, il règne une pression positive à l'intérieur de la paroi abdominale. Et grâce à ces muscles, grâce à cette paroi, on peut les contenir et les maintenir en place. L'inverse de ce qui se passe dans la cavité thoracique règne une pression négative, alors que dans la cavité abdominale règne une pression positive.

Donc à travers une zone de faiblesse naturelle, les zones de faiblesse naturelles qui siègent dans la paroi abdominale, vous devez les connaître. La ligne blanche, surtout sous son obliquale, c'est-à-dire au-dessus de l'oblique. Donc à ce niveau-là, on trouve ce qu'on appelle la ligne blanche qui est un tendon.

La ligne blanche est un tendon qui relie les deux grands droits, le droit et le gauche. Cette ligne blanche peut faire chez certains individus, depuis la naissance, elle peut être absente. Et bon, les lieux, à ce moment-là, relie de la ligne blanche au congénital.

Donc, les points de faiblesse, vous trouvez également le point de l'ombilique. L'ombilique peut être très fragilisé depuis la naissance, de manière congénitale, ou bien il peut être fragilisé au cours de la vie. Au cours de la vie, surtout chez la femme, lorsqu'elle prend l'enceinte, avec le nombre de procès, c'est très important.

Les femmes peuvent être exposées à cette pathologie qui est la hernie de l'ombilical. On a également, comme point de faiblesse, la région de l'aîne, les deux, droit et gauche. Surtout chez le sexe masculin.

Pourquoi ? Parce que l'homme, contrairement à la femme, il a la cavité abdominale qui est ouverte au niveau de la région abdominale. Vous savez très bien que les testicules se forment au cours de la vie embryonnaire, ils se forment dans la cavité abdominale, à côté des lames. Et plus le fœtus arrive à terre, plus les testicules descendent, et ils vont franchir, à un certain moment, la

région abdominale.

Par le canal abdominale, ils vont descendre dans le scrotum. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les deux testicules ont besoin d'une température inférieure à celle qui règne dans l'enceinte abdominale, de 1°C jusqu'à 2°C. Si, par exemple, la température est de 37°C dans l'enceinte abdominale, les testicules, pour être fertiles et pour qu'ils assurent et assurent leur fonction, qui est la fertilité, doivent régner une température inférieure à 1°C ou 2°C.

Donc, ce passage fragilise le long par rapport à la fin. Heureusement, il y a ce qu'on appelle ce système du canal abdominal. Grâce à l'interposition des muscles de la paroi, la cavité reste quand même étanche.

Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le corbeau spermatique passe, il décrit une marche d'escalier. Il sort par l'orifice abdominal plat. Il passe dans la paroi abdominale, dans l'épaisseur des 3 muscles.

Puis, il ressort par l'orifice abdominal cicatriciel. Ce passage permet à l'enceinte abdominale d'éviter tout ce qui est épicération et tout ce qui est hernie. On va revoir ça par détail.

Une hernie, donc, c'est le passage à travers un point de faiblesse de viscère, qui peut être l'intestin grêle, le colon, le gros intestin. Tous les viscères de l'abdomen peuvent sortir à travers cet orifice ou ce point de faiblesse. La complication majeure que vous devez connaître, qui nécessite de prendre en charge en urgence votre malade, c'est le étranglement.

Une hernie ou bien une éviscération, quand elle n'est pas compliquée, elle est réductible. On peut la réintégrer. Vous pouvez palper votre patient, appuyer sur la tuméfaction et réintroduire l'hernie dans l'enceinte abdominale.

Elle est réductible. C'est la première caractéristique d'une hernie qui n'est pas compliquée. La différence entre hernie et éviscération, c'est que l'éviscération survient quand le malade est déjà opéré.

Les anglo-saxons l'appellent hernie post-opératoire. Dans tout ce qui est éviscération, ça sous-entend que le patient a déjà eu une intervention, soit pour une hernie ou bien pour un apport autonome pour autre chose. Il se peut qu'il soit opéré, mais il n'exécute pas de voie sus-stomacale.

Suite à une complication qui peut être d'une infection, d'une hyperpression, de maladie, tous en post-opératoire, il a une infection pulmonaire, ça l'expose à développer une éviscération post-opératoire. Quand la hernie ou l'éviscération n'est pas compliquée, elle est réductible, elle n'est pas douloureuse. Elle est impulsive à la toux, c'est-à-dire que quand vous demandez à votre patient, lors de l'examen clinique, lorsque vous lui demandez de tousser, la tuméfaction est expansible.

C'est une tuméfaction fondante qui disparaît lors de l'hyperpression et qu'on peut réintroduire

dans l'enceinte abdominale. Le principe vital dépend de l'urgence. Quand le malade se présente dans votre consultation et il a une hernie anglaise, vous devez tirer l'assemblée d'alarme et lui expliquer qu'il risque pas mal de complications, qu'il risque la rétrose du contenu dans le sac herniaire, donc il doit être pris en charge en urgence, il doit être hospitalisé et opéré en urgence.

Elle nécessite un diagnostic précoce et un traitement pour prévenir cette complication. Quelle est la complication majeure quand la hernie est anglaise ? C'est que le contenu intestinal peut être nécrosé, il peut se perforer et le malade peut déclencher une péripéritonite secondaire à la perforation du contenu intestinal qui se trouve dans la hernie être anglaise, que ce soit inguinal, de la vie blanche ou indélébile. On ne peut pas parler de cette pathologie que sont les hernies et les herniations sans parler de l'anatomie de la paroi abdominale antérolatérale.

Vous savez très bien maintenant que la paroi abdominale antérieure elle est faite de ces deux muscles assez costauds, assez pollumineux étendus depuis le sternum jusqu'au pubis, le grand doigt droit et le gauche qui sont reliés par la ligne blanche, qui se comportent comme un tendon qui relie les deux muscles. Et puis latéralement, le bord externe du muscle grand doigt il est relié à la paroi abdominale par ces trois muscles. De la superficie à la profondeur, on a le muscle grand oblique et à l'oblique externe, il a des filles du muscle vert qui sont posées en bas et en dehors.

Le muscle au-dessous s'appelle le muscle oblique. Alors dans ce cas, les fibres sont obliques en bas et en dehors. C'est l'inverse du muscle grand doigt.

Et puis le muscle transverse, les fibres musculaires sont transversales. Cette ligne d'intersection avec le muscle grand doigt de l'abdomen s'appelle la ligne séminulaire. D'ailleurs, il y a des hernies qui siègent à ce niveau-là.

Ils sont rares, c'est vrai, mais il faut les reconnaître. Ils sont rares, ils sont difficiles à traiter. Et puis vous avez la région inguinale qui est très complexe, vous devez la connaître.

La ligne, ce point qui est détenu il y a 30 secondes, il est palpable. Vous pouvez le palper. Vous avez à ce point-là le point du pubis, l'os du pubis.

Et puis les deux sont reliés par la ligne de Malgaigne. Uniquement on parle de la ligne de Malgaigne. Qui correspond sur le plan anacondique à l'arc-cadre cléral, ou bien le ligament inguinal.

Donc les hernies, lorsque l'orifice d'extériorisation, l'orifice de sortie, il siège au-dessus de la ligne de Malgaigne, on les appelle les hernies inguinales. Quand l'orifice, il siège au-dessous de l'orifice inguinal, on parle d'hernie clérale. Vous avez ici les transversales jusqu'à l'endroit de la tomelle.

C'est le péricoine, le fascia transversaliste, la ligne blanche. Il y a une différence entre la région sous-ombilicale et sur-ombilicale. Cette différence, c'est exactement, c'est que la zone sous-

ombilicale, elle est trop fragile.

Elle est trop fragile, et c'est la raison pour laquelle on évite de faire des incisions sous-ombilicales. D'ailleurs, les chirurgiens océpticiens, les gynéco-océpticiens, évitent de faire des césariennes par la ligne médiane, tout simplement à cause de la fragilité et de l'exposition des patientes au risque de rentrée post-opératoire secondaire à la césarienne. C'est la raison pour laquelle ils ont développé l'incision de Tanach-T, qui est une incision basse transverse, pour éviter de passer par la ligne médiane.

Tout simplement parce que le muscle, l'endroit de la tomelle, il ne dispose pas d'une gaine aponeurotique postérieure en sous-ombilicale. Donc, une fois qu'on est en sous-ombilicale, il n'y a plus de gaine postérieure, il n'y a plus de gaine antérieure. Et ça fragilise et expose les patients au risque de rentrée post-opératoire.

Voici un schéma qui montre les points de faiblesse naturels. Chaque individu est exposé à faire une énigme au niveau de la région ombilicale. Elle peut être en génital depuis la naissance, elle peut être acquise au cours de la vie, surtout si le patient a un métier ou une profession qu'il expose au corps de chaque jour.

Donc, les travailleurs matériels, les journaliers qui travaillent durement au cours de la journée, peuvent être exposés à débloquent des énigmes au niveau de la ligne blanche et au niveau de tous les points de faiblesse. Ce point-là est aussi très important chez les femmes enceintes. Pas mal de femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, remarquent une tumefaction de la région ombilicale.

Cette pathologie peut s'aggraver au fur et à mesure du nombre de grossesses. Les femmes qui ont 2, 3, 4 grossesses sont exposées beaucoup plus à cette pathologie. On peut avoir une énigme au niveau de la ligne blanche sous-ombilicale.

Rappelez-vous qu'on a dit que les énigmes de la ligne blanche se débloquent surtout en sous-ombilicales à cause de l'absence d'aponeurose au niveau de la région sous-ombilicale. Et puis, dans la région inguinale, on peut observer ici une énigme inguinale et ici une énigme curale. La différence, c'est que l'énigme curale sort au niveau, évidemment, curale et évidemment inguinale.

Alors, les énigmes compliquées, l'interrogatoire est très important. L'interrogatoire, l'anamnèse et la discussion avec votre patient est très importante. Elle vous permet de recueillir pas mal de données avant de s'engager dans le traitement, avant de poser un diagnostic.

Donc maintenant, c'est l'importance de la séniologie, de ce cours de la séniologie. Et de la séniologie en général, vous avez vu au cours de la première année beaucoup de sciences fondamentales. Vous avez vu l'anatomie, la physiologie, la biophysique, etc.

Alors, ce sont des sciences qui ne vont pas vous servir dans votre vie professionnelle. Mais c'est

un bagage qui va vous permettre de raisonner et de penser. Donc, par exemple, si vous avez un patient devant vous qui a une double infection inguinale, c'est grâce aux connaissances et au bagage que vous avez acquis l'année précédente que vous allez pouvoir raisonner et poser un diagnostic correct.

Donc, le raisonnement clinique, c'est un processus très complexe que vous devez exercer, que le médecin doit pratiquer sans parler au malade. C'est-à-dire que le malade, il est devant vous, vous n'allez pas lui dire « Ah tiens, là tu fais partie en STG dans la région inguinale ». Donc, tout ça, tout ce raisonnement, c'est entre vous et votre conscience. Vous allez le pratiquer et rapidement.

Le raisonnement clinique, c'est un processus. C'est comme l'organisme, lorsque vous cliquez sur la recherche, la boule de l'internet commence à tourner. C'est ça le raisonnement clinique.

Donc, vous devez avoir un bagage scientifique très important. Vous devez connaître les sciences fondamentales. Mais même temps, grâce à la scéniologie et au raisonnement clinique, vous allez penser à cette double infection et à sa nature.

Vous allez vous dire peut-être que c'est une hernie. Donc, pour savoir si c'est une hernie, je vais lui demander de tousser, voir si la double infection est réductive, expansive, etc. Et vous allez caractériser cette double infection.

C'est ça le raisonnement clinique. Donc, une fois, et vous avez besoin également de l'interrogatoire. Pour arriver à un diagnostic devant une double infection inguinale, vous avez besoin de pas mal de données que vous allez recueillir à l'interrogatoire.

L'interrogatoire doit être ciblé. Donc, je vais poser des questions à mon patient, mais qui vont me servir pour arriver à un diagnostic. Je ne vais pas vous poser par exemple une question.

« Est-ce que vous êtes réveillé ce matin ? » Ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est important, c'est votre travail, monsieur. Est-ce que vous êtes déflammé ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous portez des charges lourdes dans le travail ? S'il me dit que je suis travailleur dans une usine, je porte des caisses lourdes, etc.

Tiens, ça a un rôle avec la hernie. Ça l'expose. Donc, le travail dur, ce qu'elle peut exposer, le patient a développé une hernie.

Je peux lui poser également une question sur le thalagisme. Est-ce que vous fumez ? Parce que quelqu'un qui est thalagique, le matin, il commence à tousser. Et avec la toux, il y a une hyperpression.

Et les thalagiques chroniques, ils sont exposés à développer des hernies et des électrations. D'ailleurs, on ne peut pas opérer un malade sans lui demander de faire le sevrage. Si, par exemple, vous n'expliquez pas ce détail-là à votre patient, même si vous êtes un chirurgien

excellent, etc., vous opérez le patient, et le lendemain, il va allumer sa cigarette, il risque de faire exploser toutes les sutures et tout l'attaque que vous avez posées.

Donc, c'est très important de lui poser la question sur le travail, sur les habitudes respiratoires. Est-ce qu'il est thalagique ou non ? Est-ce qu'il a des problèmes urinaires ? Est-ce qu'il... Par exemple, un patient qui a 55 ans, 60 ans, il peut être porteur d'une avalanche de la prostate, ce qui va l'exposer à développer une hernie. Donc, on ne peut pas, dès la première consultation, voir un monsieur de 60 ans qui a une avalanche de prostate, et on va le traiter pour sa hernie.

On doit explorer sa prostate, on doit demander une échographie desichoprostatique pour voir le volume, et on doit prendre un avis d'un confrère qui est urologue pour ne pas laisser un problème urinaire qui va compromettre le traitement chirurgical que vous allez délivrer à votre patient. Donc, l'interrogatoire, il va demander au monsieur qui est porteur, ou à la dame qui est porteuse d'une hernie, depuis quand, la date d'apparition de cette hernie. Vous devez la caractériser.

Normalement, une hernie, ou bien une éventration, elle n'est pas bouleveuse. Si elle est bouleveuse, ça veut dire qu'elle est tremblée. Vous devez chercher des signes d'accompagnement fonctionnel, à savoir les troupes de transit.

Par exemple, un patient qui a une hernie qui est étranglée, le transit va être arrêté. Il va avoir une occlusion. Donc, la hernie, elle peut être congénitale.

Il y a pas mal de nouveau-nés. L'examen du nouveau-né doit chercher une hernie, que ce soit de la vie blanche, que ce soit de la vie vitale. Vous allez voir certaines pathologies.

Chez le nouveau-né, il peut y avoir même une absence de la paroi dominale antérieure, ce qu'on appelle la pauschitis. Vous allez voir ça dans le cours de la chirurgie infantile. On peut avoir pas mal de pathologies.

On doit demander au patient son niveau socio-économique, sa profession, chercher les signes urinaires. On a dit qu'un monsieur, en général, qui a 60 ans, 65 ans, qui vient d'avoir sa retraite, ça cache un adhérent de la prostate. Et donc, ça peut expliquer l'apparition d'une hernie droite ou gauche, ou bilatérale parfois.

Il est obligatoire d'explorer sa prostate et de lui demander une échographie vésicoprostatique pour ne pas passer à côté d'une pathologie prostatique. On doit également chercher des signes digestifs. Un malade qui est canticipé tout le temps, qui part pour faire ses sels tous les 4 jours, 5 jours, il a une hyperpression, ça peut exploser et ça peut compromettre le traitement chirurgical.

Donc, on doit explorer, si le patient est constipé, on doit explorer sa constipation, est-ce qu'elle est fonctionnelle en rapport avec une myelopathie fonctionnelle, ou bien ça cache quelque chose, un cancer. On a offert pas mal de patients pour une hernie et on a retrouvé un cancer du frolon sous-jacent qu'on n'a pas exploré et qu'on n'a pas bien diagnosticé. Également, des signes

pulmonaires.

Il faut toujours, chaque fois que je reçois un malade qui a une hernie dans ma consultation, la première question, pourquoi ce monsieur fait une hernie ? Donc, qu'est-ce que je dois chercher ? Des signes urinaires, des signes digestifs et des signes pulmonaires. Monsieur, est-ce que vous êtes pathologique ? Vous fumez combien de paquets par jour ? Depuis combien de temps ? Le nombre de paquets années ? C'est très important. Par exemple, si le patient est jeune, il est pathologique, il est stressé, il fume 3-4 paquets par jour, la première des choses, il ne faut pas l'opérer dans la poubelle.

Il faut lui donner un peu de temps pour pouvoir faire le sevrage et le revoir en constipation pour pouvoir l'opérer. L'examen physique d'un patient qui est porteur d'une hernie doit se faire aussi bien en position debout qu'en position allongée. Debout, vous allez voir est-ce que la hernie est au niveau de la ligne médiale et au niveau inguinal, puis vous allez l'examiner en position allongée.

Bien sûr, il faut l'examiner dans une salle intime, une salle bien chauffée, bien illuminée, la lumière doit être correcte, il faut caractériser le siège de la hernie, le volume, la forme, une hernie peut-être petite, on peut avoir de grosses hernies, des hernies très anciennes, très évolutives, etc. Il peut y avoir des signes inflammatoires, ça sous-entend que la hernie est amplifiée, étranglée. On peut également, à l'examen clinique du patient, voir est-ce que la hernie est expansive à la toux ou non.

Vous devez demander au patient Monsieur, allez-y, commencez à pousser, vous allez voir est-ce qu'elle est réductible ou non. Voici un patient qui a une hernie inguinostrotale. C'est une hernie inguinostrotale droite.

Elle est inguinostrotale droite, c'est un monsieur, c'est un sexe masculin, c'est une hernie oblique externe. C'est une hernie inguinale, oblique externe. Vous allez voir que les hernies inguinales sont de deux types.

Il y a l'hernie inguinale directe et l'hernie inguinale indirecte. Donc celle-ci, c'est une hernie oblique externe. Appelée également, c'est une hernie indirecte.

C'est une hernie qui descend, le sac herniaire descend par le canal péripionio-vaginal. Donc il va y avoir une reperméabilisation du canal péripionio-vaginal. Le canal péripionio-vaginal c'est une émanation, une prolongation du péripionie lors de la descente du testicule dans le scrotum.

Donc ce canal péripionio-vaginal, il peut rester perméable après la naissance, alors que normalement il doit se fermer. C'est ce qui explique l'apparition des hernies congénitales. Comme il peut être reperméabilisé après la naissance.

C'est-à-dire qu'il a été fermé, mais vu que le patient travaille durement, il porte des charges

lourdes dans son travail, et bien vu qu'il est babagique, il tousse tout le temps, bien vu qu'il a des signes primaires, il peut y avoir une repérméabilisation du canal périmonio-vaginal. Alors le contenu intestinal, le contenu herniaire, ici c'est quoi ? C'est l'intestin grêle. C'est l'intestin grêle.

Donc vous voyez que l'intestin grêle, d'ailleurs, le patient, lors de l'examen, vous pouvez remarquer, lors de la palpation du scrotum, qu'il y a des gabouillements qui correspondent à l'intestin intestinal. Donc, hernie oblique externe, indirecte, en rapport avec une repérméabilisation du canal périmonio-vaginal. Donc, à la palpation, la palpation normalement, elle est indolore d'une hernie normalité, elle se prolonge par un pédicule, c'est pour faire une diagnostic différentielle d'une tuméfaction scrotale.

Lorsque vous avez une tuméfaction scrotale, vous allez palper le scrotum, il est volumineux, il contient une masse, mais dans le cas d'une hernie imbruloscotale, elle se continue par un pédicule. C'est-à-dire que vous allez palper ce prolongement, ici, c'est ça, il est volumineux, elle se continue par un pédicule. Dans ce cas-là, il contient l'ence intestinale et le cordon spermatique.

Alors que, normalement, si on discute d'une diagnostic différentielle, il n'y aura pas ce prolongement par un pédicule. Lorsque vous allez examiner, vous allez palper la région intestinale, vous n'allez rien trouver. Il y aura juste la funéfaction dans le cas d'une hernie dorsale, mais pas ce prolongement par un pédicule.

L'hernie disparaît lors de la pression, elle est réductible, c'est-à-dire que lorsque le patient se couche sur le dos, vous allez pouvoir réintégrer le contenu intestinal dans l'enceinte abdominale. Mais ça, c'est dans le cas où l'hernie n'est pas étranglée. Donc, elle est réductible.

Finalement, on va définir la hernie simple, que ce soit une hernie inguinale, ombilicale, ou de la ligne blanche. Une hernie simple, c'est une funéfaction indolore, réductible, expansible à la toux. Donc, si vous demandez au patient de tousser, elle sort, et puis lorsqu'elle se relâche, vous allez la réintégrer.

Elle se prolonge par un pédicule. C'est ça, les symptômes et les caractéristiques d'une hernie non compliquée, d'une hernie simple. Alors, la hernie inguinale, elle est fréquente chez l'homme, tout simplement parce que la femme, elle souffre beaucoup plus de ce qu'on appelle la hernie plurale.

La funéfaction, elle est au-dessus de la ligne de Malgaine. La ligne de Malgaine, c'est cette ligne qui correspond à la projection du ligament inguinal ou de la carte plurale. La funéfaction, elle sort au-dessus de la ligne de Malgaine.

Alors, on a vu tout à l'heure, il y a deux types de hernie inguinale. Il y a la hernie indirecte, qu'on appelle communément oblique-externe. Oblique-externe.

L'orifice, il sort par l'orifice inguinal profond. Le canal inguinal, il suit le canal inguinal, puis il ressort pour se reprendre par l'orifice inguinal superficiel. Elle se voit surtout chez les sujets jeunes.

La hernie oblique-externe. Alors que la hernie directe, elle est également appelée hernie, elle est dite également hernie de faiblesse. Elle se voit surtout chez les sujets âgés.

Lorsque vous avez un patient qui vient d'avoir sa retraite, il a 60 ans, 62 ans, 63 ans, les gens commencent à bouger moins, ils subissent une sarcopélie, c'est-à-dire que l'ensemble des muscles de leur corps vont s'atrophier par sarcopélie avec l'âge, ils vont être exposés à développer des hernies directes, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. On voit ici trois types de hernie qu'on vient de voir, ça c'est une hernie de faiblesse directe, d'accord ? C'est une hernie inguinale de faiblesse. Le sac, il reste toujours au niveau de la région inguinale.

Alors que la hernie oblique-externe, elle est inguinaux scopale. Inguinaux scopale. C'est-à-dire qu'on va avoir une re-perméabilisation du canal périméridien et on peut avoir une descente des ongles intestinaux jusqu'au niveau du scopale.

Et ici, vous avez l'hernie pleurale qui se voit beaucoup plus chez la femme. La hernie pleurale, elle est une hernie aussi très difficile. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il faut bien mettre en confiance votre patient lors de l'examen clinique pour pouvoir palper la face interne de la pousse.

Il faut, par exemple, dans le cas où la patiente est obèse, ça peut être difficile de palper la fuméfaction et le sac. Ça peut être très compliqué. Et on peut même s'aider par des examens complémentaires tels que l'échographie ou surtout le scanneur, la PDM abominable pour caractériser une hernie pleurale dans le diagnostic.

Il peut être très difficile. Donc, la hernie pleurale, de part que le diagnostic, il est difficile, la fuméfaction siège au dessous de la ligne de Malgrena. Elle sort par l'orifice pleural, par le point de sortie des gros vaisseaux, à savoir la veine fémorale et l'artère fémorale.

Donc, à ce niveau-là, on peut avoir le sac herniaire dans le canal fémoral. Donc, en dedans de l'artère fémorale, elle pose un problème de diagnostic différentiel avec des adénopathies de la région adénale, des adénopathies du triangle de Scarpa. On peut avoir une dilatation varicocelleuse de la crosse de la veine asigose qui peut poser le problème de diagnostic différentiel avec une hernie pleurale.

au moins de vous, en cas de difficulté, il faut demander une TDN de la région adénale pour faire la part des choses. Voici un schéma anatomique pour voir cette région-là. Vous avez ici l'épine iliaco-antérosupérieure.

Mettez le doigt sur l'épine iliaco-antérosupérieure. Ici, vous avez le pubis et les deux poings sont reliés par une corde fibreuse qui s'appelle l'artère plurale. Il y a un ligament interne et qui

correspond au bord inférieur de la fonébrose du muscle grand-oblique.

Le muscle oblique externe ou grand-oblique, son bord inférieur est entre deux cet artère plurale ou ce ligament inguinal. Grâce à cette corde-là qui assure l'étanchéité de l'enceinte abdominale. Remarquez que les hernies inguinales chelantes sortent par cette fente-là.

Pour développer beaucoup plus ce schéma anatomique, on peut dire que à ce niveau-là, il y a une pellicule vasculaire qu'on appelle une pellicule épigastrique. L'artère est l'artère épigastrique. L'artère qui remonte par là est l'artère épigastrique.

Alors, lorsque le collet de hernie sort en dedans du pellicule épigastrique, on parle d'hernie directe. Hernie de faiblesse directe chez le sujet âgé. Donc, à ce niveau-là, on a les hernies de faiblesse.

Et en dehors du pellicule épigastrique, on a les hernies obliques externes. Obliques externes, c'est-à-dire les hernies du sujet jeune. Ici, vous avez le pendent en joint.

C'est un ligament qui relie deux muscles à savoir le transverse et le petit oblique. Le transverse et le petit oblique. Ici, le pendent en joint.

Ici, vous avez le muscle grand droit de l'abdomen. D'ailleurs, dans les cures de la hernie, on peut utiliser des plaques de pollen, des mèches, pour assurer l'étanchéité de cette zone-là. Le meilleur traitement d'une hernie incriminale, c'est la mise en place d'une prothèse.

Une prothèse, c'est une plaque de pollen. La meilleure structure qui résiste à l'infection, à la chirurgie, ce sont les plaques de pollen. Ce sont les plaques de pollen.

Et le principe des plaques de pollen, c'est des filaments qu'on compose d'une plaque. Ce n'est pas la plaque qui va rassurer l'étanchéité de la région incriminale. La plaque va servir de tuteur à la cicatrisation.

Quand vous êtes chirurgien et que vous mettez en place une plaque de pollen pour une hernie, la plaque va déclencher un processus inflammatoire dans les heures qui suivent sa mise en place. Jour après jour, ce processus inflammatoire va laisser en place des fibroblastes qui vont s'installer dans cette prothèse et ils vont commencer à synthétiser du collagène. On va assister deux mois, trois mois après à l'apparition d'une néo-aponébrose.

C'est-à-dire que vous allez aider l'organisme à générer une nouvelle néo-aponébrose qui va assurer l'étanchéité de la région incriminale. Donc la plaque, quand vous entendez les patients parler de chycanthermie, c'est pas la plaque qui va assurer tout le temps l'étanchéité et la solidité de la paroi incriminale. La plaque, elle sert de tuteur à la cicatrisation à l'organisme pour qu'il déclenche l'apparition d'une néo-aponébrose.

C'est extraordinaire lorsque vous allez rentrer au bloc et voir un patient opérer dans le passé

avec une plaque. Vous n'allez pas trouver la plaque. Vous allez trouver un tissu de collagène très épais, très solide qui est à ce niveau-là.

Donc la plaque, quand on va la mettre à ce niveau-là, on doit la tailler, c'est-à-dire qu'on doit la découper pour qu'on laisse quand même la sortie du content spermatique. Donc la difficulté du traitement chirurgical avec la mise en place d'une plaque de cette zone-là, c'est que vous devez calibrer le passage, vous devez laisser quand même un petit percuit pour le passage du cordon spermatique. C'est ce qu'on appelle le calibrage.

C'est-à-dire que ce corifice ne doit pas être trop lâche, trop large. Sinon, il va favoriser le récurrence de l'AMI. Il ne doit pas être trop serré.

Sinon, il va entraîner une friction des vaisseaux du cordon spermatique et le patient s'en va remonter. Le lendemain de l'intervention, un modèle scrotale très important devient une décoloration du fuscopan. Donc la plaque doit être mise en place mais on doit calibrer le passage du cordon spermatique.

L'aéronome médical, on peut l'observer chez les malades chirotiques. Vous savez très bien que les malades chirotiques qui ont une insuffisance hypodermique souffrent de ce qu'on appelle l'acide. L'acide, c'est-à-dire la présence d'un liquide dans l'enceinte abdominale, est l'acide.

Elle peut gêner, elle peut favoriser, elle peut exposer un récurrence après un traitement chirurgical. Donc on ne peut pas piéger une AMI chez un malade qui est chirotique, qui souffre d'une acide sans traiter l'acide. Donc il faut le préparer, le patient, il faut le préparer, lui donner des traitements médicaux pour assécher le liquide en lui prescrivant des hydratants.

Une fois l'acide asséché, on peut, dans ce cas, opérer le patient qui a une cirrhose ou une amputation de l'ombilical ou de la bivanche. La grande complication à craindre chez un patient, c'est l'étranglement herniaire. Donc pas mal de fois vous allez être consulté par vos patients, ils vont vous poser la question est-ce que c'est grave docteur, est-ce que je peux ne pas être opéré.

Il faut les sensibiliser au risque d'étranglement parce que en cas d'étranglement, il risque pas mal de choses, il risque le décès par infection, par périphrite, etc. Donc la meilleure des choses c'est d'orienter, d'expliquer le patient, il faut l'orienter vers un chirurgien pour qu'il soit opéré, à reposer, tranquille, sans stress d'urgence et le patient va pouvoir choisir le moment de son intervention, le dernier le lieu de l'intervention, mieux que de le laisser non sensibilisé et s'il est opéré en urgence. Donc modification des caractères de la hernie qui devient douloureuse dans ce cas-là, la douleur est permanente lorsque la hernie est étranglée, elle n'est plus impulsive à la toue, c'est-à-dire que la tuméfaction elle est là, même si vous demandez au patient de pousser, elle ne bouge pas, le volume il est le même, sinon avec la douleur c'est très douloureux et irréductible, on ne pouvait pas la réintroduire dans l'enceinte abdominale et on va avoir en plus l'apparition du site fonctionnel des vomissements et un arrêt des matières et des lasses.

Donc le monsieur qui avait tout à l'heure une hernie ombilicale qui a l'apparition des encoches, s'il s'en est étranglée, il va tenir un syndrome d'occlusion. D'ailleurs parmi les étiologies, on va voir la semaine prochaine la sémiologie des occlusions et on va voir que parmi les étiologies il y a l'étranglement herniaire. Donc le patient s'il a une hernie étranglée, il va commencer à avoir des vomissements alimentaires, un ballonnement abdominal, une distension abdominale très importante et un arrêt des matières et des gaz.

Voici l'aspect intestinal, c'est pour vous montrer. Remarquez cette encoche intestinale qui est nécrosée. Elle a changé de couleur.

Elle est attendue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de péristaltisme. Il n'y a plus de peau mais c'est enterré. Donc la viabilité de l'encoche intestinale elle est compromise.

La viabilité de l'encoche intestinale, on peut la juger sur trois éléments. On peut la juger sur la couleur, une encoche qui est violacée, noirâtre, verdâtre et une encoche qui est nécrosée. Une encoche où on ne parle plus de peau mais enterrée.

Elle est nécrosée et une encoche que lorsqu'on la stimule par les doigts il n'y a plus de péristaltisme. Il n'y a plus de mouvement de réflexion. Ça veut dire que c'est une encoche qui est morte, qu'il faut la réséquer.

Dans ce cas-là, il faut réséquer et anastomoser. Il faut faire la résection et l'anastomose pour créer l'œsophage terminale. Vous voyez le risque que pose le patient quand il n'est pas sensibilisé pour se faire opérer à temps.

Maintenant que vous avez un patient dans votre consultation, vous devez lui expliquer le risque de nécrose plutôt que de le laisser sans être conscient de ce risque-là. Quand on fait la laparotomie, quand on opère un patient, on doit laisser un peu de temps avant ce testinal pour voir si elle peut reprendre la couleur ou non. On ne doit pas être brutal.

Dès qu'on voit cet aspect, on commence à réséquer. Il faut se donner un peu de temps. Parfois, l'encoche lorsqu'elle est désincensée dans le prolifère, elle peut reprendre les couleurs, elle peut se recolorer.

L'encoche peut devenir rose, rouge, elle peut reprendre le péristaltisme. Donc on peut sauver l'encoche intestinale plutôt que de la réséquer. Parce que la résection, quand on résèque l'encoche intestinale, on couvre des risques que sont le lâchage asthmatique, la désunion.

Il n'y a aucun chirurgien qui est à 100% de risque de complication post-opératoire. Donc, il faut laisser un peu de temps et espérer une reprise, une recoloration. Même si l'encoche est violacée, elle est bleuâtre, elle peut reprendre les couleurs.

Ici, vous voyez, il manque une demi-argente avec l'encoche qui est 2A, nécrosée. Donc, la conduite

à tenir, c'est de la désincarcérer et de l'inhiber par poussière entière et de attendre 2, 3, 4, 5 minutes, parfois, l'ance peut se recolorer si la nécrose n'est pas installée d'une manière définitive. L'examen physique d'une herpie est anglais.

Une thyméfaction pendue, la thyméfaction, elle est pendue, bouleveuse au niveau du collet, elle est irréductible et le malade, il est plus ou moins altéré sur le plan général. Et voici les caractéristiques d'une herpie, elles sont anglaises. Voici une thébène, un scanner avec une coupe transverse, une coupe frontale qui manque une herpie, c'est quel type d'herpie ? Une herpie non-frontale, oblique-externe, c'est une herpie oblique-externe.

Avec une descente d'aissance intestinale, une descente d'aissance intestinale. Alors, les éventuations, c'est presque la même chose, la seule différence, c'est que de façon, il a été déjà opéré. C'est issu des viscères à travers les ongles des femmettes, ça peut être post-opératoire comme ça peut être post-traumatique.

Le patient peut avoir dans ses ongles un coup de couteau, d'accord ? Il peut y avoir une éventration au niveau de ce point de couteau. Comme on peut avoir des éventrations post-opératoires, même les orifices de cellules peuvent donner des éventrations post-opératoires. Les facteurs favorisants, c'est la surinfection de la plaie, le volume, il est variable, ça peut être une petite éventration comme ça, ça peut être une volumineuse éventration.

Voici une compte, une vue, c'est une vue per-opératoire lors de l'acédo d'une hernie ingrénale. Donc ici, on est à l'intérieur de l'enceinte abdominale avec l'optique, avec la cellule et on regarde de derrière la paroi, la face extérieure de la paroi abdominale antérieure. Ici vous avez cette zone-là et vous avez la sortie de l'ence intestinale et vous avez le fond du sac herniaire.

D'accord ? Ici, qu'est-ce qu'on trouve sur le fond arthropodique ? Qu'est-ce qu'on trouve sur le fond arthropodique ? On a vu tout à l'heure les schémas, les... C'est le structure. Très bien. Je comprends.

Ici, c'est le fond arthropodique. C'est le périphore qui retrouve le fond arthropodique. Et ici, qu'est-ce qu'on va voir ? L'argane clorale.

Donc le traitement, il faut expliquer au patient le traitement. C'est une parologie qui peut être très difficile. Les malades sont exigeants et il faut leur expliquer le risque de récidence.

Les facteurs favorisants. La première des choses que vous devez vous poser, pourquoi ce patient a fait une hernie ? C'est pas normal. C'est pas normal qu'un patient fasse une hernie.

Vous avez fait le diagnostic de la hernie, mais il faut développer dans votre raisonnement clinique pourquoi il a fait la hernie. Est-ce qu'il a un problème respiratoire ? Est-ce qu'il n'est pas vagique ? Est-ce qu'il a un problème urinaire ? Est-ce que le patient est âgé ? Est-ce qu'il a un problème de la prostate ? Tout ça, il faut le résoudre avant de commencer et de s'engager avec le patient

dans un traitement. Par exemple, quand je reçois un monsieur d'un certain âge, 65 ans, 70 ans, à l'entraînement urinal, je lui demande systématiquement de l'hypocratie vésicoprostatique pour que je puisse évaluer sa prostate.

Parce que c'est l'âge de la démarche de la prostate. Tous les hommes, je dis bien tous les hommes, développent la démarche de la prostate. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'hyperprofil des lignes de la prostate.

Tous les hommes, je dis bien tous les hommes. Même si 60% ou 40% des hommes, tous les hommes développent la démarche de la prostate. Sauf que, il y a ceux qui développent la démarche de la prostate à l'âge de 70 ans, il y a ceux qui le développent à l'âge de 80 ans, il y a ceux qui décèdent à 65 ans et qui n'ont pas eu l'occasion d'exprimer cette démarche de la prostate.

Mais la démarche de la prostate, c'est comme un processus de vieillissement de la prostate qui, pendant un temps, va arriver au stade du problème urinaire. Donc tous les hommes sont, il ne faut rien expliquer au patient, il faut lui expliquer même l'anesthésie. Si vous avez conféré le patient à tête reposée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence, on peut lui faire une anesthésie loco-régionale et donc il faut expliquer cette anesthésie.

L'anesthésie, si on ne l'expliquait pas, ça ne peut pas marcher. Même si on réussissait le geste et le malade, il est anesthésié. Si on n'avait pas bien expliqué au patient, il ne va pas admettre que vous allez l'opérer, il est réveillé, il est en train d'écouter et de voir ce qui se passe dans la salle.

Donc il faut bien expliquer l'anesthésie loco-régionale. C'est-à-dire que vous allez lui dire écoutez monsieur, on va vous faire une anesthésie, vous n'allez plus ressentir la moitié inférieure de votre corps, mais vous allez rester éveillé, conscient, vous allez avoir les yeux ouverts dans le bloc opératoire et c'est comme ça qu'il va admettre et vous allez mieux que ça, vous allez sentir, vous pouvez le sentir, vous toucher, travailler, sauf que vous n'allez pas sentir la douleur. C'est ça la ration anesthésique.

Si vous n'expliquez pas tout ce qu'on a dit maintenant, le malade ne va pas admettre que dès que vous allez commencer à parler à l'opérateur et que vous allez lui dire donnez-moi la lame, il va en prendre la lame, il va paniquer, il va... même si il n'a pas l'âge. C'est pour ça que j'ai dit il faut expliquer au patient, même l'anesthésie, il faut lui expliquer l'anesthésie. Au mesure que vous allez nous entendre travailler, vous n'allez rien sentir, vous allez vous allez sentir le toucher avec la machine anesthésique, le patient il sent le toucher, il sent l'étirement, je suis en train d'écarter, etc.

Mais vous n'allez pas sentir la douleur, parce que la machine elle dort uniquement la douleur per opératoire et post opératoire. Donc il faut bien expliquer au patient et les marqueurs favorisant et la machine anesthésique, il faut expliquer le mal qu'il vit et il faut l'intégrer, il faut que le patient lui-même intervienne dans la décision de quelle technique il faut qu'il participe. Parce que si vous

vous opérez un tabagique, un jeûne, qui vient, vous le voyez par exemple à 11h du matin, et vous l'opérez un dit, et vous n'avez même pas parlé du tabac, le tabac n'a rien à voir avec la veille.

Et vous allez terminer l'intervention, le lendemain il est dans sa salle, il est en train de fumer un cigarette, c'est comme si vous n'avez rien fait, même si vous avez posé là correctement une technique parfaite, etc. Il va commencer à tousser et il va vous faire tout le travail que vous avez fait la veille en l'air. Donc, intégrer le patient dans la prise en charge, régulation professionnelle, s'il travaille dans une usine, par exemple une porte d'écharpe d'eau, on peut, avec un petit mot au directeur ou à l'employeur, il peut le reclasser.

Donc tout ça, il faut le prévoir avant le test chirurgical, éviter le port d'écharpe d'eau. Certains sports, par exemple, un jeûne il ne peut plus faire de l'arthérophilie, il ne peut plus aller à la salle et faire des mouvements de musculation, il peut en donner un revoir. Le sport, il ne fait plus.

Par exemple, il peut faire du footing, il peut faire de l'animation, il ne fait pas de l'arthérophilie ou etc. Comme certains sports, arrêter le shabat et discuter avec le gynécologue, les scientifiques éventuels, c'est un process. Voici la plaque.

On a parlé tout à l'heure de plaques de problèmes. Ces plaques de problèmes ont l'avantage c'est qu'elles donnent moins de risques d'infection post-opératoire. Voici la fente pour laisser passer le corbeau spermatique.

Vous voyez la fente ici. Dans cette plaque, on va la mettre en place pour traiter les lingues. On va la fixer sur le pubis, sur l'arcade creval à ce niveau-là et sur le conjoint à ce niveau-là.

Il y a deux grandes techniques. Il y a les rapides et les structures d'entre-brosses. On peut opérer quelqu'un et ne pas lui faire une plaque pour une raison ou une autre.

On peut utiliser la technique de Bassini, la technique de McVey. Sinon, la meilleure c'est l'utilisation de plaques. Voici une vue perforatoire par scénioscopie de la région inguénable.

Ici, on voit l'orifice inguénable profond qui correspond à l'orifice herniaque. Ici, c'est le corbeau spermatique qui descend. C'est quel type d'herbie à ce niveau-là? Inguénable, oui.

C'est une herbie. C'est une herbie externe. C'est une herbie.

Ici, vous avez la fissure et les intestins. On peut traiter les herbies par scénioscopie. Voici une plaque fixée par scénioscopie dans la région inguénable.

La fixation se fait par ces pores-là qu'on appelle les pagaires. C'est des extensions chromatiques qui permettent une fixation de cette plaque et c'est une plaque biface. Une plaque biface parce que cette face en contact avec les ancêtres destinables ne pose pas de problème en principe.

Voici une technique géologique qui consiste à des rames, à des sutures. On appelle le Bassini. Avant, on situe le ligament creval avec le tendon conjoint.

Bien sûr, en calibrant et en laissant le passage du cordon spermatique, de l'orifice intestinal profond. Voici une technique qui s'appelle le Lichtenstein. C'est la mise en place d'une plaque de pollen fixée à ce niveau au tendon conjoint en bas, à l'arcade fibrale et en calibrant, laissant le passage au cordon spermatique.

Le cordon spermatique, vous rappelez, contient des éléments mortaux, à savoir l'artère spermatique, la veine spermatique et le canal déférent, le canal excréteur des vésicules. La technique ici s'appelle la technique de Lichtenstein. En conclusion, on va dire que la hernie et les éversions sont des diagnostics privilégiés.

Il faut différencier dès le départ ce qui est hernie et éversion. On les différencie par une question. Il faut aller au général et observer la présence d'une veine antérieure.

Si le patient est porteur d'une laparotomie, d'une cicatrice de laparotomie, c'est qu'il a été déjà opéré. En bas, on sait plutôt à l'éversion qu'on s'occupe de la veine. Dès le départ, vers la veine, il y a une hernie et l'éversion.

Il faut expliquer au patient le risque et les risques de l'épidémie antérieure et le traitement. Merci.